

		☒ ACOMPANHAMENTO		☐ CONSULTA	
		NS		22.231697041 900	
Marina Massako Zah Stender					
IDADE:	83	PESO:	99	ALTURA:	1,56
SINTOMAS:		nega boca seca / Desanimada			
QUEIXAS:		Calor Pesado / 4 de PA / Sonolência			
MEDICAMENTOS:		Atenolol / Rosuvast / AAS / Cogfiv / Labirin.			
MÉDICO: Dr. Zampor / Dr. Alexandre					
MARCAPASSO:		☐ S ☒ N		COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: ☐ S ☒ N	
EXERCÍCIO FÍSICO:		Não faz			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		S		ALMOÇO:	S
				LANCHE:	S
				JANTAR:	(30ms)
HORA QUE DORME:		22-23		HORA QUE ACORDA: 5h	
COCHILO ☒ SIM ☐ NÃO		DORME ACOMPANHADO ☐ SIM ☒ NÃO ☐ EVENTUAL			
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM ☐ NÃO		X NA SEMANA ☐ NÃO <i>lambrusco</i>			
FUMO ☐ SIM ☐ MAÇO/DIA ☒ NÃO		- PAROU A QUANTO TEMPO: —			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		nasal			
BANHEIRO:		OX			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		normal			
CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:					
OVERLAP:		não		MALLAMPATI:	
IAH:				SPO2:	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:					
CIRURGIAS: ☐ NASAL ☐ AMIGDALECTOMIA					
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:		Não		IMC:	
COMORBIDADE:		☐ RESPIRATÓRIA		☒ ENDÓCRINA	
				☒ CARDÍACA	
☐ ORTOPÉDICA		☐ NEUROLÓGICA		☐ OUTROS	
12/11/24		P = 4-8 cmH ₂ O		automático	
12/12/24		P = 6,3 cmH ₂ O			
		IAH = 0,3 e/ev			
		m. de uso: 5h10'			
Relatox que melhorou o peso da cabeça					
relata melhora da sonolência. — fua.					
Comprou o CPAP.					
10/01		P = 6,4 cmH ₂ O		30 d / 23 d / 14 d. 44 ms	
25		IAH = 4,9 e/ev		9 d ↓ 4 ms	
		m. de uso: 5h10 ↓		7 d s/ uso	
		fuga = 62.3 pm ↑		melhora da dor de cabeça.	
Oriento novamente					
Tere rinite					
28/04		P = 6,4			
25		IAH = 1,1			
		fuga = 62,6		fua	

Nome: MARINA MASSAKO ZAHIA TENDER

Data de Nascimento: 21-5-1941

IMC: 20,13

Sexo: Feminino

Data do exame: 07-06-2024

Peso: 49 kg

Altura: 1,56 m

Médico: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 07-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 527,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 6,0 e 85,0 minutos. O tempo total de sono foi de 433,5 min, eficiência de 82,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 54,3%; estágio N3: 22,6%; sono REM: 21,5%. O índice de despertares foi de 0,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 0,8/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 6 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 91%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 38 - 77 bpm e NREM de 40 - 71 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. Antonio Carlos Zampa
Medicina do Sono
CRM 57157